

ORDONNANCE DE SEVRAGE D'ALCOOL LÉGER À
MODÉRÉ POUR LA CLIENTÈLE ADULTE (18+)
INTRAHOSPITALIÈRE ET DU CRDL

Associée aux Protocoles médicaux nationaux (PMN) de l'INESSS n° 888021 et 888027

Poids : _____ Taille : _____ Allergies : _____

SEVRAGE D'ALCOOL

LABORATOIRES

- | | |
|---|--|
| ☐ FSC | ☐ ALT et AST (inscrire renseignement obligatoire : Hépatite alcoolique) |
| ☐ Na, K, Cl | ☐ INR |
| ☐ Créatinine | ☐ Bilirubine totale |
| ☐ Glycémie aléatoire | ☐ GGT |
| ☐ Mg | ☐ PALC |
| ☐ Alb | ☐ B-HCG (femme en âge de procréer) |

SI FACTEURS DE RISQUE DE ITSS

- Hépatite B : ☐ HBsAg **ET** Anti-HBs
- Hépatite C : ☐ Anti-VHC **OU**
☐ Recherche de l'ARN du VHC (si Anti-VHC +)
- ☐ VIH ☐ Syphilis ☐ Autres : _____

ATTENTION Surveillances infirmières et précautions au verso

ORDONNANCES PHARMACOLOGIQUES GÉNÉRALES

Pour tous les usagers :

- ☐ Médicaments usuels represcrits
- ☐ Maalox (ou équivalent) 15-30 mL PO QID PRN si dyspepsie
- ☐ Pantoprazole 40 mg PO DIE
- ☐ Lax-a-day 17 g (ou équivalent) PO DIE PRN si constipation
- ☐ Lactulose 15 à 30 mL PO BID PRN si constipation non soulagée par Lax-a-day
- ☐ Metoclopramide 10 mg PO QID PRN si nausées ou vomissements
- ☐ Quétiapine 25 à 50 mg PO BID PRN si anxiété ou obsessions
- ☐ Quétiapine 25 à 50 mg PO HS PRN si insomnie

Pour usagers avec contre-indications*

- ☐ Quétiapine 12.5 à 25 mg PO BID PRN si anxiété ou obsessions
- ☐ Quétiapine 25 à 50 mg PO HS PRN si insomnie

Prophylaxie de l'encéphalopathie Wernicke

Si risque élevé de carence en thiamine

- ☐ Thiamine 500 mg IM ou IV DIE x 3 doses puis Thiamine 100 mg PO TID

Si risque faible de carence en thiamine

- ☐ Thiamine 250 mg PO BID x 3 jours puis Thiamine 100mg PO DIE

* CONTRE-INDICATIONS

- Usagers de plus de 65 ans
- Insuffisance hépatique sévère
- Insuffisance pulmonaire sévère ou chronique
- Hépatite alcoolique
- Apnée du sommeil
- Myasthénie grave
- Glaucome aigu à angle fermé

ORDONNANCES PHARMACOLOGIQUES SPÉCIFIQUES

A. Si score CIWA-Ar < 8 et FC < 110 :

- Observation
- Surveillances infirmières, échelle CIWA-Ar (voir verso)
 - Poursuivre médication benzodiazépines régulière si déjà débutée
 - Si FC ≥ 110 débiter Diazépam ou Lorazépam selon prescription

****Pour l'urgence** : ne pas utiliser FC du triage, recontrôler sur civière

Diazépam

Si contre-indications* prescrire plutôt Lorazépam

NB : Pour une alternative aux benzodiazépines, se référer au PMN

B) Si score CIWA-Ar ≥ 8 et < 20 :

- ☐ Consommation ROH < 20 DIE
Diazepam 10 mg PO QID x 48 h, TID x 48 h, BID x 48 h, DIE x 48h **ET**
Diazepam 10 mg PO q 1 h PRN si CIWA-Ar ≥ 8 **ou** FC ≥ 110

- ☐ Consommation ROH ≥ 20 DIE
Diazepam selon même dosage que la section C

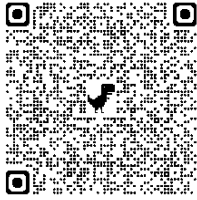
C) Si score CIWA-Ar ≥ 20 (lorsque section C débutée, cesser doses section B)

- ☐ Diazepam 20 mg PO QID x 48 h puis 20mg PO TID x 48h puis 10mg PO QID x 48h puis Diazepam 10mg PO TID x 48 h puis 10mg PO BID x 48h puis 10mg DIE x 24-48h **ET**
Diazepam 10 mg PO q 1 h PRN si CIWA-Ar ≥ 8 **ou** FC ≥ 110

Lorazépam (si contre-indications* au Diazépam)

- ☐ Lorazepam _____ mg (sugg : 2-4mg) PO/SL QID x 48 h, TID x 48 h, BID x 48 h, DIE x 24-48 h **ET**
Lorazepam _____ mg (sugg : 1-2 mg) PO/SL q 1h si CIWA-Ar ≥ 8 **ou** FC ≥ 110
(Lorazepam 1 mg = Diazepam 5 mg)

Date : _____ Heure : _____ Signature du médecin : _____ N° de permis : _____

SURVEILLANCES INFIRMIÈRES		
PARAMÈTRES		FRÉQUENCE DES SURVEILLANCES INFIRMIÈRES (SV ET CIWA-AR)
○ CIWA-Ar initial < 8 ET FC <110 ○ Aucune administration de benzodiazépines		q 1 h
○ CIWA-Ar < 8 ET FC <110 ○ Après début d'administration de benzodiazépines		q 1 h x 4 puis
		q 2 h x 4 puis
		q 4 h x 4 puis
		q 8 h ad 72 h
○ CIWA-Ar ≥8 OU FC ≥110		q 1 h
AVISER MÉDECIN SI ○ Après le début des benzodiazépines régulières : ○ Si 3 scores CIWA-Ar consécutifs ≥ 8 qui ne diminuent pas ○ Si 3 scores CIWA-Ar consécutifs ≥ 15 ○ Si 2 scores CIWA-Ar ≥ 20 ○ Si tachycardie (≥110) persiste malgré 2 benzodiazépines prn administrées ○ Si température buccale > 38,5, changement abrupte de l'état de conscience, convulsions, diplopie, hallucinations ○ Si administration > 12 mg de Lorazepam ou 60 mg de diazépam en 12 h ATTENTION Ne pas administrer de benzodiazépines si : • Échelle de sédation ≥ 2 • Saturation en oxygène ≤ 92 % AA • Rythme respiratoire ≤ 10/minute		
RECHUTES OU TRAITEMENTS ALTERNATIFS Si vous souhaitez initier une prescription pour la prévention des rechutes (gabapentin ou autres), veuillez-vous référer au Protocole Médical National (PMN-888027) « Initier un traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes chez une personne avec un trouble lié à l'usage d'alcool » de l'INESSS.		
Vidéos explicatifs pour l'utilisation du formulaire		Légende des symboles
Médecins 	Infirmières et infirmières auxiliaires 	< : plus petit que > : plus grand que ≤ : plus petit ou égal à ≥ : plus grand ou égal à
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux Québec Pour plus d'informations sur les PMN Sevrage d'alcool n° 888021 et Prévention des rechutes liées à l'usage d'alcool n° 888027 (INESSS, 2024) :		
Auteurs : Dre Kawthar Grar, médecin en médecine des toxicomanies; Marie-Lyne Erazola et Samira Nabil, conseillères cadres DSI; Dre Alexanne Champagne Provost et Dre Delphine Rémillard-Labrosse, urgentologues; Caroline Leblanc, pharmacienne.		